

--

Name: فاتن حسن احمد حسن National ID: 26609050102389	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تعريف شخصية

فتن

حسن احمد حسن

٦ ش النور سلطان البلد

طوان - القاهرة

١٩٩٦/٠٩

٢٦٦٠٩٠٥٠١٠٢٣٨٩

LL5889606



٢٠٢٥/١٠ ٢٦٦٠٩٠٥٠١٠٢٣٨٩

بدون عمل



أنثى مسلمة متزوجة

حسن ابراهيم ابراهيم حسن

البطاقة مارية حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٩

١



Patient ID: 88528	Patient Name English: Faten Hassan Ahmed
Age: 31	2025/10/08 11:08:46 AM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Name: Faten Hassan Ahmed

Date: 8-10-2025

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: left breast mass mass lesion since 2 weeks

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- Oval shaped well circumscribed mass lesion in the right upper outer quadrant with fatty hilum.
- Ultrasound demonstrated well circumscribed mass lesion oval shaped lesion measures 10 x 5 mm along the main dimensions, likely lymph node
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- Mass lesion is noted at the upper outer quadrant, such lesion is hypodense irregular shape, irregular margin.
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound
- Irregular shaped, irregular margin hypoechoic mass lesion is noted at 10° clock zone A in parareolar location, and about 2 mm underneath the skin surface, measures about 21 x 14 x 14 mm along the main dimensions.
- Left axillary suspicious looking lymph node measures about 14 x 8 mm along the main dimensions with focal thickening of the lymph node measures 4 mm.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BI-RADS 2): benign looking mass lesion with features suggestive of Intramammary lymph node

Left breast (BI-RADS 4B): moderately suspicious mass lesion as described above with suspicious looking ipsilateral axillary lymph node

Recommendations:

Left breast: True cut needle biopsy from the detailed suspicious mass lesion

regards,

Best

Dr. Hekmat Samir .md

Patient Name : الأستاذ / فائق حسن احمد
Patient No. : 26609050102389
Path No. : 3533/25
Sex : Female
Age : 59 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003436
Request Date : 16/11/2025
Verification Date : 25/11/2025
Financial Category : جيمتال روي - مياره
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/11/2025, at 10:32 am, Cold ischemia time: 3 minutes.

Gross Examination:

- Five grey white tissue cores, the longest was 1.5 cm. Totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;

- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

* Histological type: Invasive duct carcinoma.

* Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).

* Necrosis: Focal.

* DCIS: Absent.

* Angiolinvasion: Present.

* Perineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).

- PR: Weak nuclear reaction in 1% of tumor cells (score 3/8).

- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).

- Ki67%: 45%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 02/12/2025 10:20:53

Page 1 of 3

Printing by : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأمثلة / لبن حسن احمد	Request No. : 13003436
Patient No. : 26609050102389	Request Date : 16/11/2025
Path No. : 3533/25	Verification Date : 25/11/2025
Sex : Female	Financial Category : جوماتك رومسي - مبادره
Age : 59 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 3/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 45%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Hiba El-Shafeey.

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 02/12/2025 10:20:53

Page 2 of 3

Printing By : marwa mohamed youss



عزلة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية للنظم المعلومات والتحول
الرقمي

رسم الاستلام 20 جارية

تاريخ الإصدار: 2025-11-13

جهة الإصدار: بلع القاهرة

إلى من يهمه الأمر
الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للتأمين الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاملات
والإيراميل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "
الإبطال دون العين المعمرى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعمره .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التماريفات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

المستفيد (ة) فائق حسن أحمد حسن بطاقة رقم 26609050102389

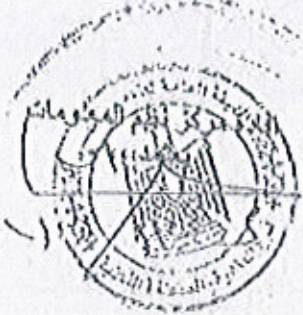
تاريخون رقم: 01153114377

وطبقا إلى الفصل أو استقاله أو انتهاء مدة خدمة
يعتبر من الفئات غير المستفيعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادلى مسئولية على الهيئة
العامه للتأمين الصحي حتى خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

الموظف المختص

تاريخ الطابعه: 2025-11-13

بسمه سرور



مستقبل 1826021



الخطاب مرفى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا أن خاتمه كغيره حقه المواطن من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية للنظم المعلومات والتحول الرقمي

رقم الملف:

تقریر طبعی

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

إيماء الطالب المقدم من

بسم رقم طبي

نفسرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج.

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

Post Card

CT Class Problems

Polis w/ context

محریر افسانہ

الوقت:
الامتحان:

الطبيب المعالج

يَعْنِي

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

جوستاف
روستاف
المستشفى
وال

تقرير طبي

الميد /

تحية طبية وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من

قسم. رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج.

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

تاريخ الحالة خيبة heart failure

يقع سرير المريض الرضالة في سرير 10 C.C. و يقدر

الـ C.C. و بدأت العلاج حتى سهر عارض

و لم يلاحظ اي علامات موجودة (خسوف)

لنفس عودت و هو في المستشفى

CT CFF $\Rightarrow$ No negative or osseous
or pulmonary metastasis

تحريراً في free of any metastasis

التاريخ: 1 / 1

الوقت:

الطبيب المعالج

الآن جرت و بلغت 5 جرات لهاوى
تساوى و تضاج للتح خسوف

يقطد

15/10/2015

و قبل الصبح

Name : Faten Hassan Ahmed Hassan
Branch : Dokki

Date : 14-01-2026 11:41
Medical No. : 294978

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- A 57-year-old lady, with history of left breast cancer.

Technique:

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions could be seen over the surveyed skeleton to account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة و السكان
المجالس الطبية المتخصصة
الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة



خطاب إدارى

الرقم القومى	٢٢٦٠٩٠٥٠١٠٢٣٨٩
إسم المواطن	فاتن حسن احمد حسن
تاريخ اللجنة	٢٠٢٦٠٨٠١٤
رقم الطلب	٢٢٦٠٩٠٤٩
الحالة	خطاب إدارى
نص الخطاب	
الأبحاث الدالة على عدم الانتقل	
جهة الإرسال	جوسناق روسي انتر ناسيونال - مصر (EPE) *
تاريخ الإرسال	٢٢٧١٤ / ٢٢٨٩ / ٢٨٦٦٦

د/ محمد حجاز
الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة
مدير عام

تصديقاً في ٢٠٢٦٠٨٠١٤
٢٢٧١٤ / ٢٢٨٩ / ٢٨٦٦٦